# 外科学 腹部和肠道疾病

## 核心精讲·腹部损伤

（性感认识：对比实心和空心器官）
- 实心脏器:脾、肝、胰
- 空心脏器:空肠、十二指肠、结肠、直肠

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、分类

车祸　刀(锐器)伤

①闭合伤 VS 开放伤：腹部皮肤是否完整

**闭合伤以脾最常见**（约 50%），**开放伤以肝最常见**（开干、其它都是屁）

腹部损伤脾最常见

②非穿透伤 VS 穿透伤：腹膜是否完整

穿透伤的入口、出口与伤道不一定呈直线，伤口大小与伤情的严重程度不一定呈正比 子弹枪伤

### 二、临床表现

1.出血

①表现：Hb↓、BP↓甚至早期休克、肠鸣音减弱消失、移动性浊音

大概率出血比较多,导致失血性休克　>1000ml液体

腹腔内出血(外面)-肠鸣音↓(抑制)
消化道内出血(里面)-肠鸣音↑(刺激)

②出血明显的器官：脾、肝、胰等实质脏器，尤其脾、肝。胰腺在腹膜后，早期腹腔内血液少（移动性浊音不明显），血液积聚在腹膜后可伴腹膜后血肿、感染（腹膜后血肿最主要并发症）

血库　双重血供

2.腹膜炎 血液对腹膜的刺激最轻 e.g 肝癌破裂因失血量很大可以出现早期休克,但只有轻度的腹膜刺激征

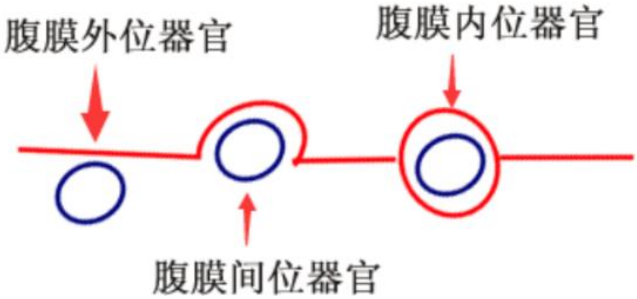
①表现：腹膜刺激征（压痛/反跳痛/肌紧张）、肠鸣音减弱消失、移动性浊音

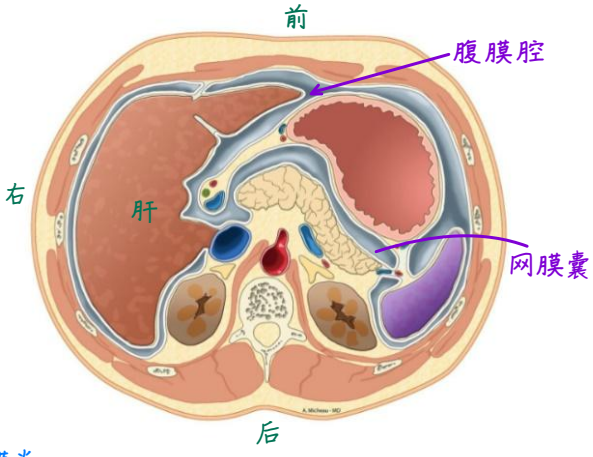
②各器官特点：

| | |
|---|---|
| 脾 | 腹膜炎早而轻<br>（早-与腹膜关系密切；轻-血液对腹膜刺激最轻微） |
| 肝 | 腹膜炎早而重 胆汁对腹膜刺激强 |
| 胃前壁、空回肠、十二指肠 1 部 | 腹膜炎早而重 都装着消化液 |
| 胃后壁、十二指肠 2/3 部、胰 | 腹膜炎晚而重（晚-腹膜外位/腹膜后器官）虽然在腹膜后,但是都是消化液 |
| 大部分结肠、直肠上段 | 腹膜炎晚而重（晚-水少）太干,不容易扩散 |
| 直肠下段 | 无腹膜炎（腹膜反折以下） |

胃后十二水平降,胰输直下肾肾上

腹膜外位/腹膜后器官：胃后（胃后壁）十二水平降（十二指肠 2/3 部）、胰输（输尿管）直下（直肠下段）肾肾上（肾上腺）早期不会出现腹膜炎




无论腹膜内位器官还是腹膜间位器官都被腹膜包裹,所以早期可以出现腹膜炎

腹膜外位器官一开始出现一些渗出、出血,会先进入网膜囊,然后再进入腹膜腔,所以一开始腹膜炎不会很明显